SDD 137 Sujet n°1

Spécialité : Psychiatrie, Gynécologie-obstétrique

Date : 20/01/2024
Auteur : RAVEL Anaïs (DES Psychiatrie, ECN 2023)
Relecteur(s) : ELAYLI Robin (DES Psychiatrie, ECN 2023), Lucie-Lou VIAL (DES MAR, EN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/ interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	
Item(s) en lien avec la station	Item 69 - Troubles psychiques de la grossesse et du post-partum
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 137 : Trouble psychiatrique du post-partum
Matériel nécessaire à la station	- Un bureau - 2 chaises
Contexte de la station	Appel pour psychiatrie de liaison sur suspicion d'une dépression du post-partum

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne en médecine générale.
Vous recevez Madame G, 27 ans, qui a accouché de son premier enfant il y a un mois.
Elle vous est adressée par les sage-femmes de la maternité pour une évaluation de l'état psychique de la patiente. En effet, dans le mail qu'elles vous ont adressé, elles expliquent que Madame G a une histoire de vie traumatique et un parcours de PMA de 3 ans et s'inquiètent donc de son état psychique en post-partum.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Réaliser un entretien avec Madame G
- Enoncer votre hypothèse diagnostique

Vous ne devez pas :

- Rechercher un diagnostic différentiel
- Prévoir d'examen complémentaire
- Orienter la patiente

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Station avec patient standardisé

TRIGGER WARNING (Violence sexiste et sexuelle) : Ce sujet traite d'éléments pouvant déclencher des rappels traumatiques ou d'autres symptomatologies traumatiques. Nous préférons vous prévenir à l'avance.

Les éléments en rapport avec la patiente simulée de ce sujet sont fictifs, toute ressemblance avec des éléments de la réalité est purement une coïncidence.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
Rubrique 1 : Terrain			
1.	Recherche des antécédents psychiatriques personnels	1 pt	☐
2.	Recherche des antécédents psychiatriques familiaux	1 pt	☐
3.	Recherche une consommation de toxiques (au moins 2 parmi : alcool, tabac, drogue)	1 pt	☐
4.	Recherche au moins un antécédent obstétrical parmi : ● Interroge le parcours PMA (durée, nombre de FIV) ● Interroge de potentielles fausses-couches ● Interroge sur des antécédents de pathologie obstétricale ou gynécologique ● Interroge sur des antécédents du conjoint à l'origine des difficultés à procréer	1 pt	☐
Rubrique 2 : Péripartum			
5.	Recherche des complications lors de la grossesse	1 pt	☐
6.	Recherche des complications lors de l'accouchement	1 pt	☐
Rubrique 3 : État psychique actuel			
7.	Recherche une tristesse de l'humeur	1 pt	☐
8.	Recherche une aboulie	1 pt	☐
9.	Recherche une anhédonie	1 pt	☐
10.	Recherche de trouble du sommeil	1 pt	☐
11.	Recherche de perte d'appétit	1 pt	☐
12.	Recherche des idées d'infanticide	1 pt	☐
13.	Recherche des idées suicidaires	1 pt	☐
14.	Pose le diagnostic de bon état psychique	1 pt	☐
Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)			

1.	**1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair**	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

2.	**2. APTITUDE À QUESTIONNER**	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

3.	**4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE**	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

4.	**5. COMMUNICATION NON VERBALE**	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

TOTAL (max 20 items)	**X points**

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

- Madame G, 27 ans, vient d'accoucher de son premier enfant il y a 1 mois, les sage-femmes lui ont demandé de rencontrer le psychiatre de périnatalité car elles craignaient qu'une dépression du post-partum se développe compte tenu des antécédents psychiatriques et du parcours PMA de 3 ans

Plan de la station ECOS :

- 1 Bureau
- 2 Chaises
- Patient.e simulé.e et candidat.e assis.e de part et d'autres de la table

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

- "Bonjour docteur, je viens à la demande des sage-femmes. Je crois qu'elles vous ont envoyé un courrier. »

Identité du patient :

Madame G., 27ans, femme
1m65, 56kg

Mode de vie :

- Vit dans une petite maison avec son compagnon, en couple depuis 7 ans (ensemble depuis qu'elle a 20 ans, il l'a beaucoup aidé à aller mieux dans son

vécu traumatique), aucun problème entre eux

- Travaille en tant juriste dans une association féministe : Solidarité Femmes (métier qui a peut-être un lien avec son histoire de vie…), se sent bien au travail, bon ambiance avec ses collègues, aime beaucoup le fait de pouvoir aider les femmes en difficulté

- A encore ses parents qui sont mariés, bon lien avec eux, a 2 petits-frères de 21 et 24 ans qui font des études d'ingénieurs, s'entend très bien avec eux, se réunissent pour des repas de famille tous les premiers week-end du mois

- Aucune consommation d'alcool, de tabac ou de toxiques (a un peu fumé du cannabis au lycée avec des copains mais jamais plus d'un joint qui tournait lors d'une soirée)

Comportement global :

Plutôt détendue, heureuse d'avoir accouché, elle est plutôt souriante (elle a compris pourquoi le psychiatre vient la rencontrer mais pense que ce n'est pas nécessaire)

Antécédents personnels :

- Abusée sexuellement par son oncle lorsqu'elle était enfant (vécu traumatique), n'en a parlé que tardivement,

- Dépression à l'âge de 15 ans dans la période du procès

- Tentative de suicide à l'âge de 16 ans dans le contexte dépressif (unique tentative de suicide), a été hospitalisée en pédopsychiatrie pendant 1 mois, ça s'est bien passé, ensuite, elle a eu un suivi auprès d'une psychologue pendant 5 ans et va beaucoup mieux maintenant

- parcours PMA : difficultés à concevoir car son compagnon avait un spermogramme altéré (ne se souvient plus de quelle manière), n'arrivait pas à tomber enceinte pendant 2 ans donc sont allés consultés en centre PMA, ont fait plusieurs FIV et c'est la 3ème qui a fonctionné

- pas d'antécédent de fausse-couche, pas d'antécédent d'enfant mort né

Antécédents familiaux :

- Grand-mère maternelle a de l'hypertension artérielle

Symptômes positifs :

Grossesse	- Vomissements et nausées lors du premier trimestre (mais s'y attendait) - Aucune complication lors des 2ème et 3ème trimestres - A adoré sa grossesse, sentir bouger son bébé, aller aux échographies…
Accouchement	- Accouchement par voie basse spontanée, à 39 semaines d'aménorrhées, sans outils - Plus douloureux que ce qu'elle imaginait, ils n'ont pas eu le temps de poser la péridurale donc elle a tout senti - Pas de complication - Arrivée d'un petit Lucas, eutrophe, en bonne santé, pas besoin de réanimation - Ne se sent pas traumatisée
Post-partum	- A pu rentrer à la maison au bout de 3 jours - Pas de complication du post-partum - Allaitement maternel exclusif, tire son lait pour que son compagnon puisse donner le biberon de temps en temps - Ils dorment peu mais se relaient la nuit pour que chacun puisse se reposer - Tous les 2 ont posés des congés pour prolonger leur congé maternité ou paternité et profiter de Lucas
État psychique actuel	- Se sent heureuse dans sa nouvelle vie de maman - Pas de tristesse, pas de sensation de vide interne - Pas de trouble du sommeil - Pas de perte d'appétit - Pas de perte de plaisir (= anhédonie) - Pas de perte d'envie et/ou de difficultés à faire les choses (= aboulie) - Pas d'idées suicidaires - Pas de pensée d'infanticide ou de pulsions